

Chap5-02. 소화불량 및 흡수불량 [요약]

Maldigestion and Malabsorption | AFMCP Chap5

핵심 원인 및 치료

원인	주요 기전	임상 단서	치료
위산 부족	H.pylori, PPI, 노화, 스트레스	역설적 역류, 식후 팽만	베타인 HCl + 펩신
소화효소 부족	췌장 기능 저하, 점막 효소 결핍	지방변, 가스, 영양결핍	광범위 소화효소 복합제
담즙 이상	담낭 절제, 담즙정체, 저섬유 식이	지방 소화 불량, 지용성 비타민 결핍	소 담즙 추출물 (ox bile)

임상 핵심 포인트

- 역류 증상 = 위산 과다? - 저산증도 역류 유발 가능, PPI 처방 전 평가 필수
- 지방변 = 담즙 또는 췌장 리파아제 문제 - 담낭 절제 환자 특히 주의
- 가장 간단한 개입: 충분히 씹기 + 식전 부교감신경 활성화
- HCl 보충 전 위궤양/NSAID 사용 여부 반드시 확인